

REHABILITACIÓN EN REUMATOLOGÍA

Reumatismo no articular – Bursitis y
Tendinitis

Lic. Cesar Borja Arenas
T.M. en Terapia Física y Rehabilitación

Presente.



Reconocer las principales características clínicas de la bursitis y tendinitis y los
Presente.
de tratamiento fisioterapéutico.

Semana 06: Reumatismo no articular – Bursitis y tendinitis

Bursitis

1. Concepto
2. Signos y síntomas
3. Tipos
4. Valoración
5. Objetivos
6. Programa

Tendinitis

1. Concepto
2. Signos y síntomas
3. Tipos
4. Valoración
5. Objetivos
6. Programa

Presente.





“Afección musculo
esquelética

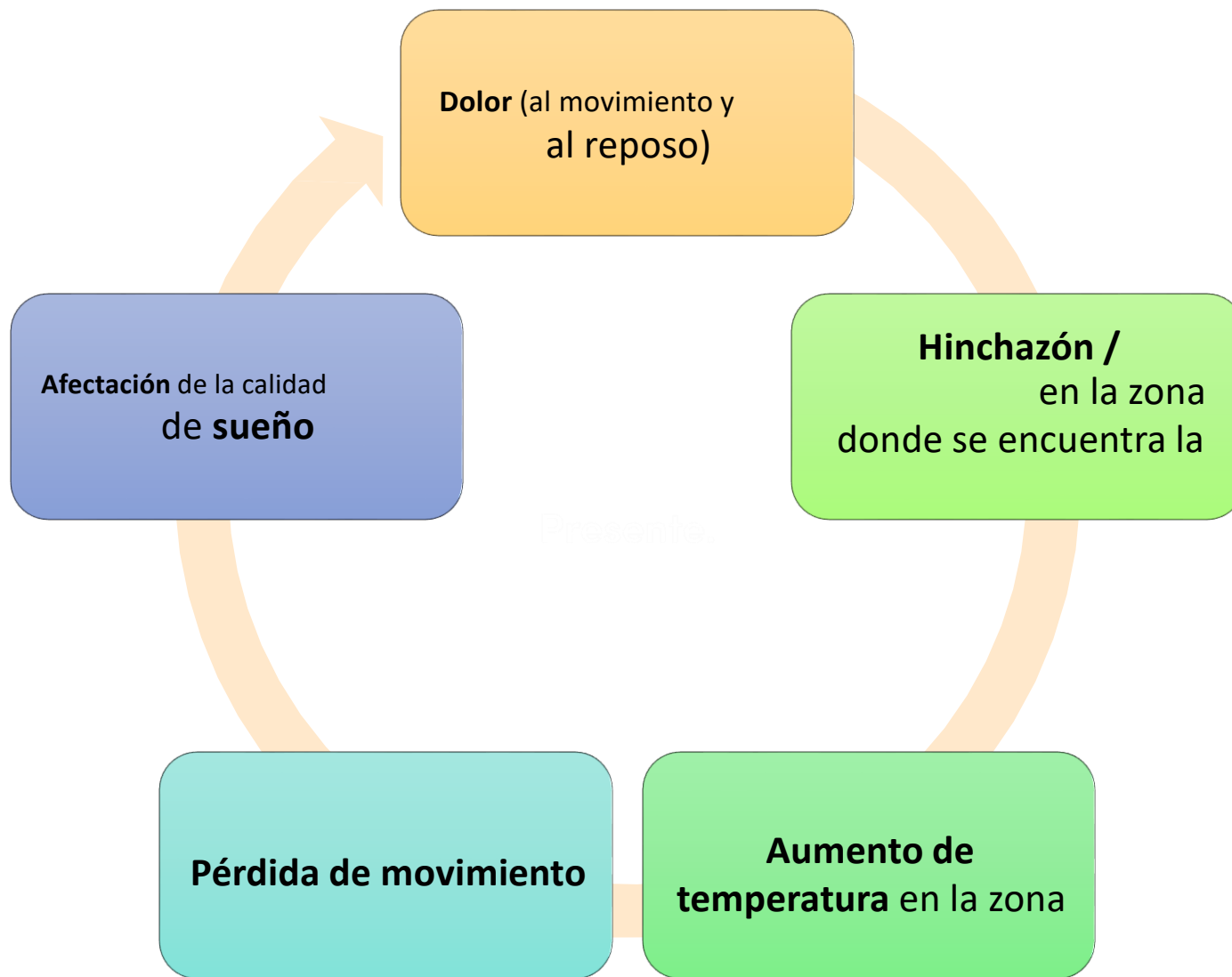
la inflamación de
una bursa”

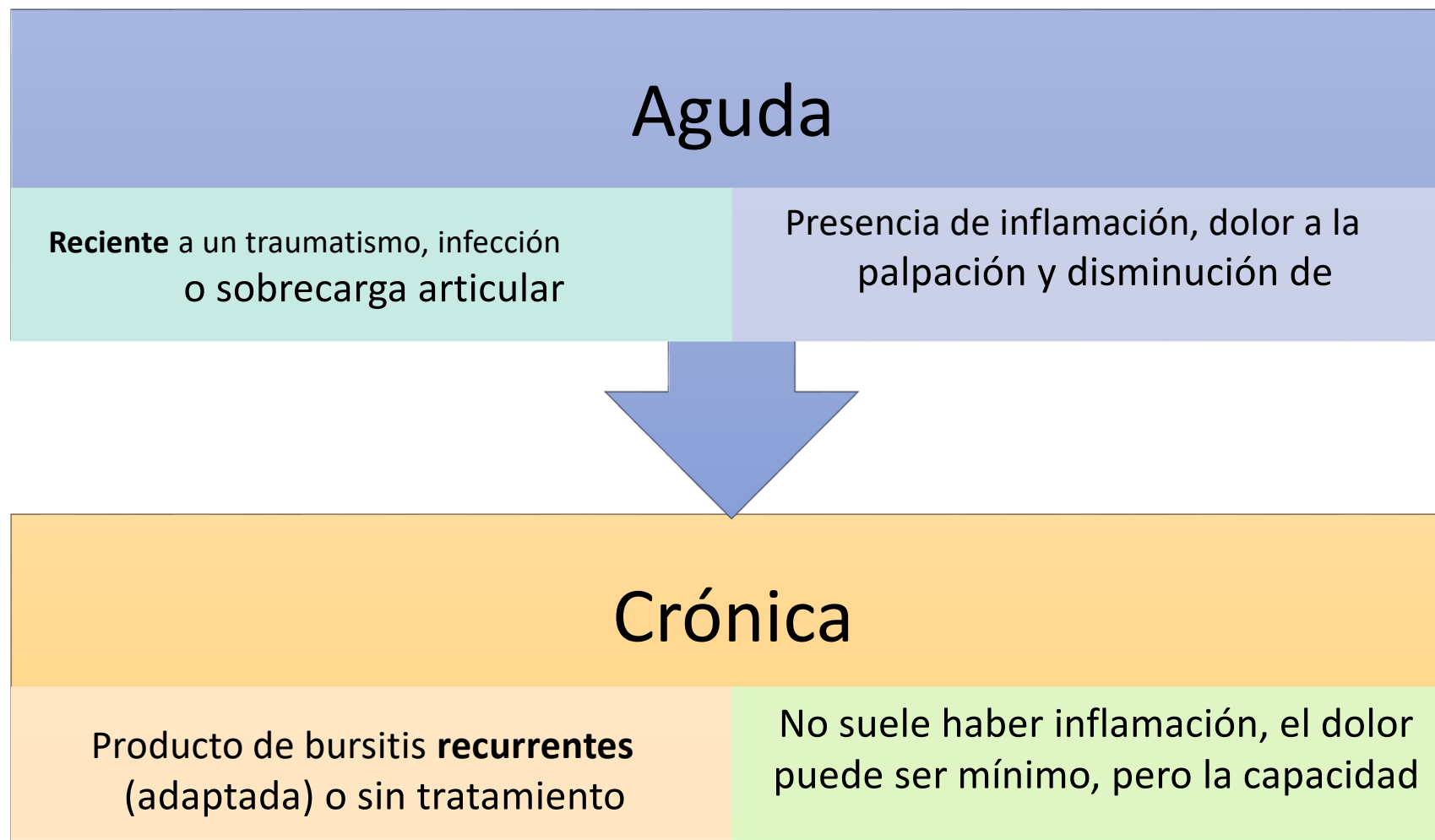
Las bursas son estructuras en forma de en su interior (150 apróx en nuestro cuerpo).

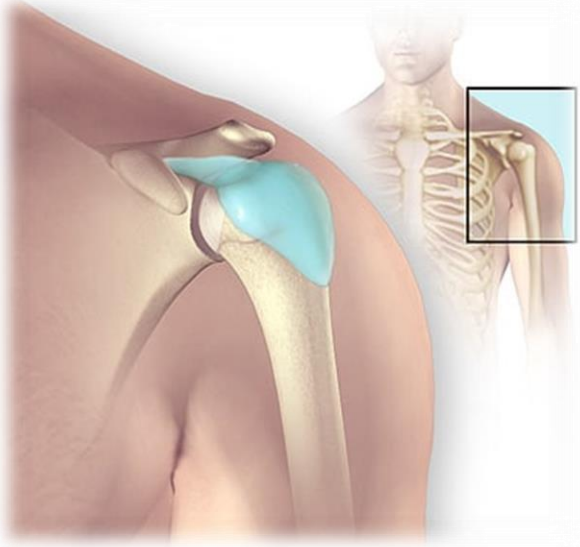
Se ubican **cerca de prominencias óseas** y y tendones.

Proporcionan a las estructuras musculo desgaste y estrés mecánico.

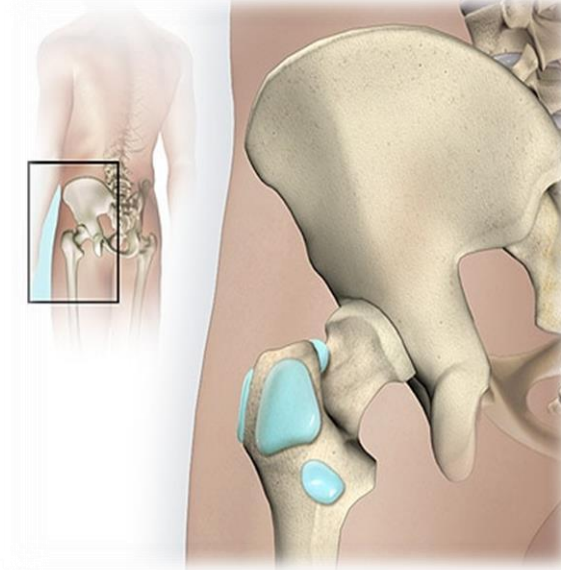
Los **factores de riesgo** más comunes son los infecciones, movimientos repetitivos.





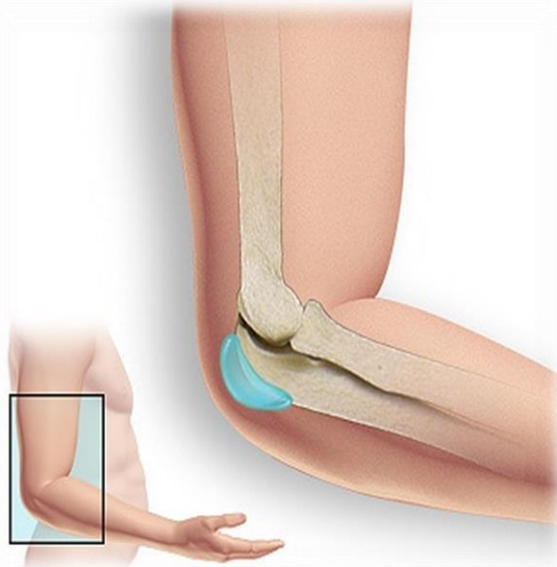


**SUBACROMIAL -
SUBDELTOIDEA**

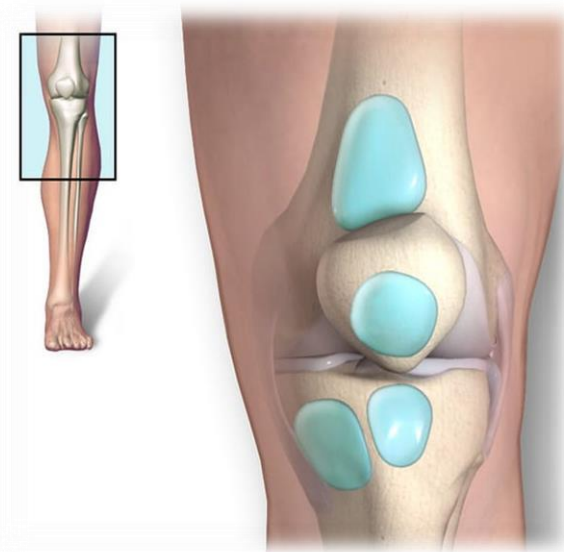


TROCANTÉREA

OLECRANIANA



**PREPATELAR –
SUPRA/INFRAPA
TELAR**





Evaluación médica



Examen físico
detectar signos y
relacionados a la
bursitis.

Pruebas de ^{imagen} el
y realizar
:
magnética

Estudios de
laboratorio en casos
de
causa

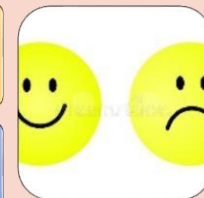
Evaluación fisioterapéutica

Entrevista sobre antecedentes, factores de riesgo, ocupación y características clínicas.



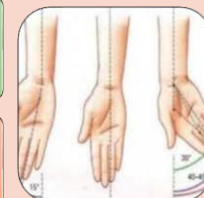
Inspección de la zona afectada para visualizar presencia de **inflamación** o **cambios en la piel**.

Palpación de estructuras comprometidas o cercanas al punto doloroso.



Valoración de las características del **dolor** según EVA.

Exploración de los **rangos articulares** y **fuerza muscular** de la zona afectada y cercana.



Medición de la capacidad funcional en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

Disminuir la inflamación y dolor

- Disminución de carga
- Crioterapia (SI HAY O NO INFLAMACIÓN)
- Ultrasonido terapéutico – Magnetoterapia (SI HAY O NO INFLAMACIÓN)
- Electroterapia analgésica (TENS)



Presente.

Aumentar el rango de movimiento

- Masoterapia en tejido cercano (NO SOBRE BURSA)
- Estiramientos asistidos y también autoaplicados



Presente.

Mejorar la fuerza muscular

- Ejercicios isométricos para musculatura anexa con la
- Ejercicios de fortalecimiento que permitan un mejor soporte y propiocepción de la zona

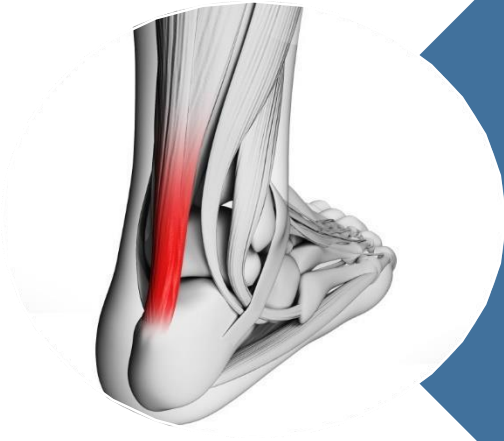


Presente.

Potenciar la funcionalidad (ABVD y AIBD)

- Evitar actividades de alta carga que comprometan la bursa
- Evitar el reposo absoluto
- Realizar actividades que se acoplen a sus actividades ocupacionales





“Afección musculo
esquelética

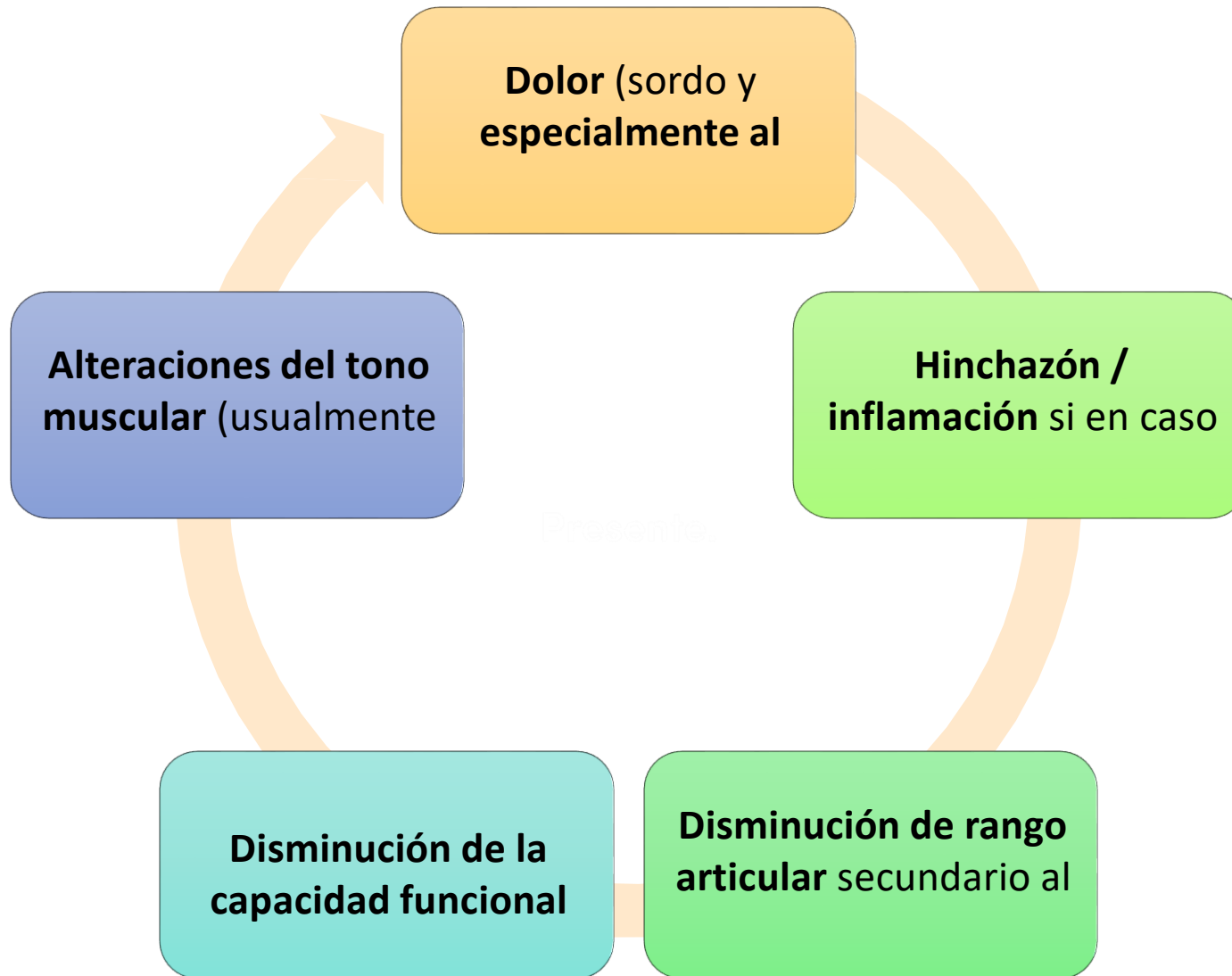
inflamación o
irritación de un

Los **tendones** son **estructuras fibrosas** que hueso.

Su **función** es **dinámica** puesto que intervienen musculares de diversas articulaciones.

Si la alteración solo afecta al tendón puede **tendinitis** o **tendinosis**; si afecta tendinosa se denomina **tenosinovitis**.

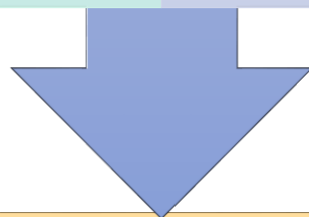
Los **factores de riesgo** más comunes son los repetitivo o sobrecarga muscular y los



Aguda (Tendinitis)

Reciente a un traumatismo o sobrecarga muscular

Presencia de inflamación, dolor a la palpación y disminución de movimiento



Crónica (Tendinosis)

Producto de la mala adaptación del tendón y de una cicatrización inadecuada del tejido

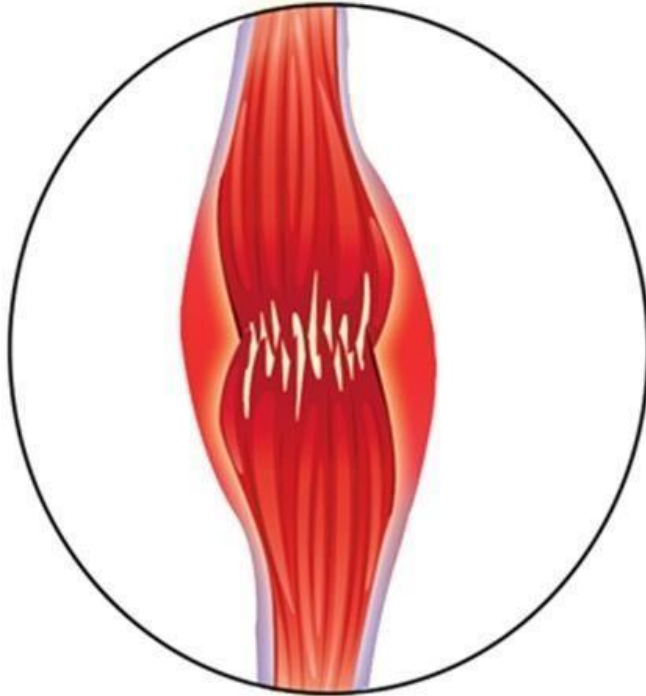
Presente.
No suele haber inflamación, pero el dolor limita la movilidad de la articulación (sobre

Tenosinovitis

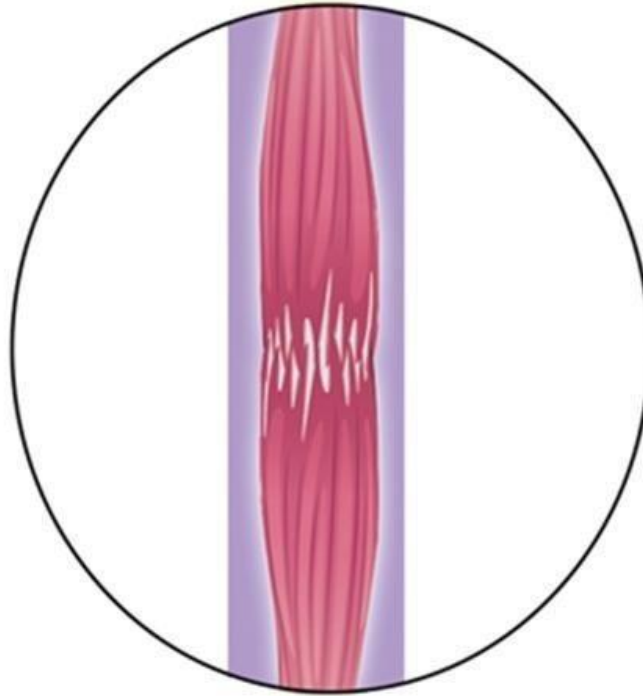


Inflamación de la vaina sinovial tendinosa asociada a una tendinopatía

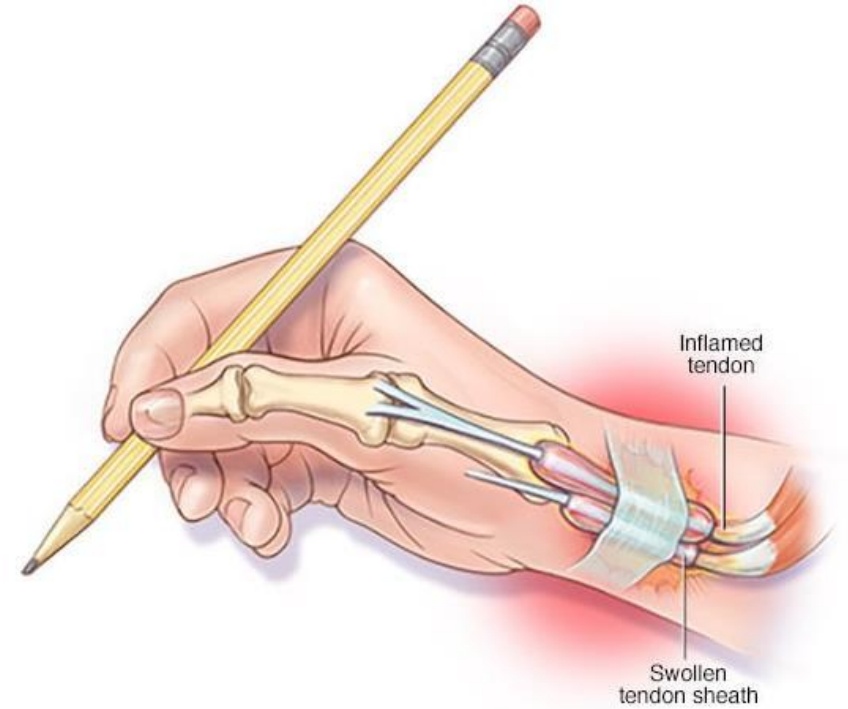
Tendinitis

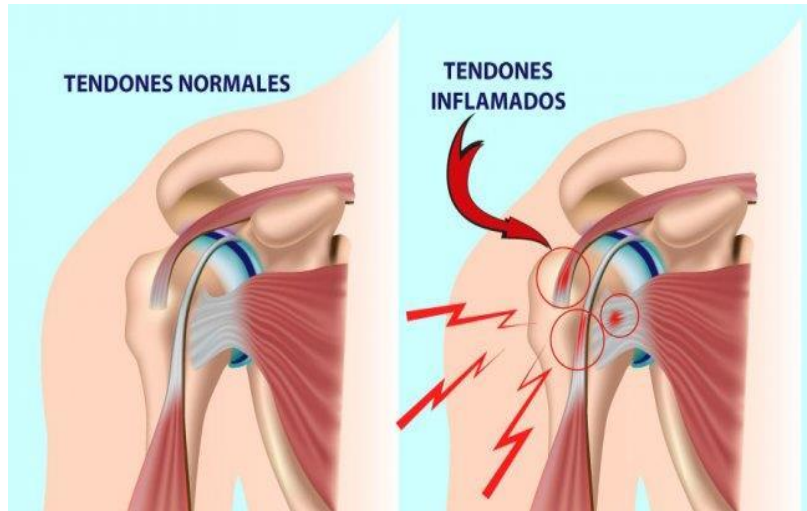


Tendinosis

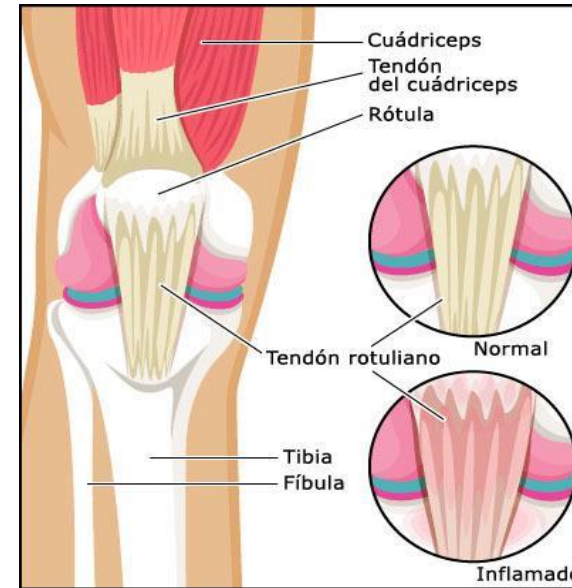


Tenosinovitis



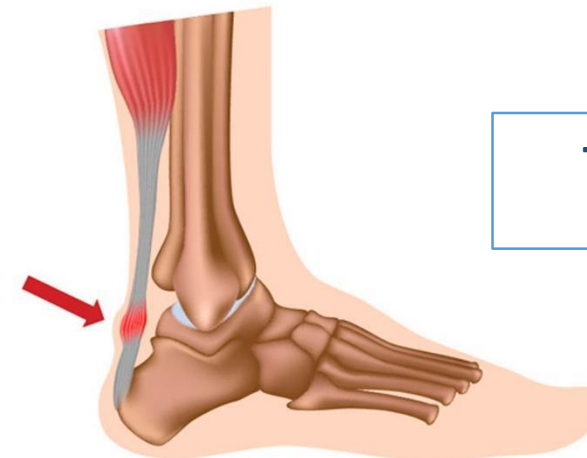
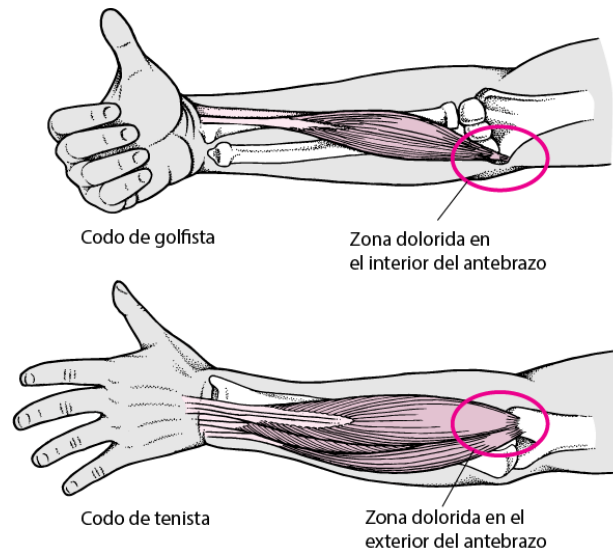


Tendinitis del Manguito
RM, SE, BB, PM)



Tendinitis rotuliana – del cuádriceps

Epicondilitis lateral y medial



Tendinitis aquiliana



Evaluación médica



signos y síntomas

**Pruebas de imagen para
diagnóstico diferencial:
o
ultrasonografía.**

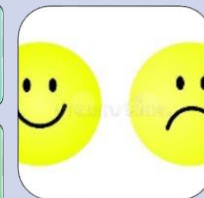
Evaluación fisioterapéutica

Entrevista sobre antecedentes, factores de riesgo, ocupación y características clínicas.



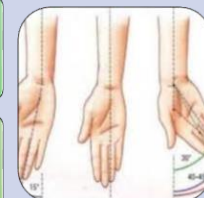
Inspección de la zona afectada, cambios posturales, piel y tumefacción.

Palpación de estructuras comprometidas (tendón y musculatura anexa).



Valoración de las características del **dolor** según EVA.

Exploración de los **rangos articulares** y **fuerza muscular**.



Medición de la capacidad funcional en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

Disminuir la inflamación y dolor

- Crioterapia localizada (tendón)
- Terapia combinada (TENS analgésico y US de mediana a baja intensidad)
- Termoterapia (CHC) en musculatura comprometida



Presente.

Aumentar el rango de movimiento

- Masoterapia sobre la musculatura
- Estiramientos asistidos de musculatura acortada



Mejorar la fuerza muscular

- Ejercicios isométricos, asistidos, libres y resistidos
- Fortalecimiento de la musculatura estabilizadora

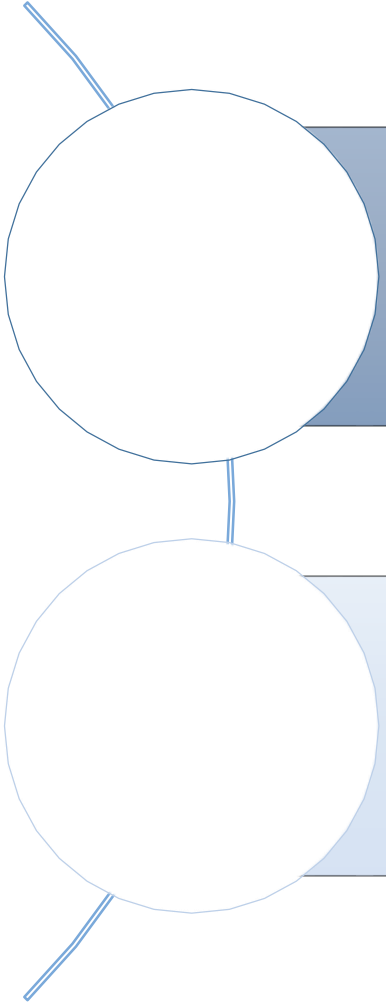


Presente.

Potenciar la funcionalidad (ABVD y AIBD)

- Promover la actividad desde un principio
- Evitar el reposo absoluto
- Realizar actividades que se acoplen a sus actividades ocupacionales y que busquen optimizar el rango de





1. Una bursitis es una afección caracterizada por la inflamación de una bursa, tejido que cumple la función de amortiguar y permitir la adecuada movilización de múltiples tejidos musculo esqueléticos presentando forma crónica por casos recurrentes, puede no haber inflamación, pero si marcada limitación funcional.

Presente.

2. La tendinitis es un tipo de tendinopatía (el tendón cumple una función dinámica al intervenir en el proceso de contracción y relajación muscular) que presenta cuadros inflamatorios, dolor al movimiento y funcional. Al presentarse de forma crónica toma la denominación de tendinosis, flexibilidad.

- https://smiba.org.ar/curso_medico_especialista/lecturas_2022/Bursitis.pdf
- <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/390GER.pdf>
- <https://www.rheumatology.org/Portals/0/Files/Tendinitis-Bursitis-Espanol-Fact-Sheet.pdf>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/tendinitis/symptoms-causes/syc-20378243#:~:text=La%20tendinitis%20es%20la%20inflamaci%C3%B3n,justo%20afuera%20de%20la%20articulaci%C3%B3n.>

Presente.

PREGUNTAS ACLARACIONES



Analizar el caso clínico en grupos y plantear un programa de tratamiento

planteadas por el TM.

Luis Miguel tiene 42 años y es entrenador de fútbol con más de 15 años de experiencia y trabajo ininterrumpido; sin embargo, desde hace 15 días comenzó con un dolor intenso (EVA 8) en el talón derecho que le imposibilitó caminar y mantenerse mucho tiempo de pie. Tras la evaluación médica (ecografía) se diagnosticó una bursitis retrocalcánea asociada a una tendinitis aquiliana en dicho miembro inferior. A la evaluación

de pie derecho. A la inspección se evidenció una tumefacción de ambos tejidos junto a un aumento de temperatura local. Al palpar, se halló un mayor tono muscular en gastrocnemios y una mayor tensión en la fascia plantar, lo que se acompaña de una menor flexibilidad de la cadena posterior. La fuerza muscular del tobillo no es evaluable debido al dolor, pero en rodilla mantiene un nivel 4.



MUCHAS GRACIAS

Presente.